

# HERNIES DE L'AINE ET ETRANGLEMENT HERNIAIRE

## GENERALITES :

- Pathologie très fréquente.
- 1 homme / 10 concerné au cours de sa vie.
- Pronostic: bon.
- formes compliquées: MEFIANCE+++.
- Diagnostic souvent aisé → Examen clinique.
- Compréhension des mécanismes physiopathologiques et anatomie canal inguinal → essentielle.

## DEFINITION :

- La hernie pariétale est l'issue de viscères digestifs entourés d'un sac péritonéal à travers un point de faiblesse de la paroi abdominale (collet herniaire).

3 types :

1. Hernie inguinale (90%),
2. Crurale (5%)
3. Ombilicale (5%)

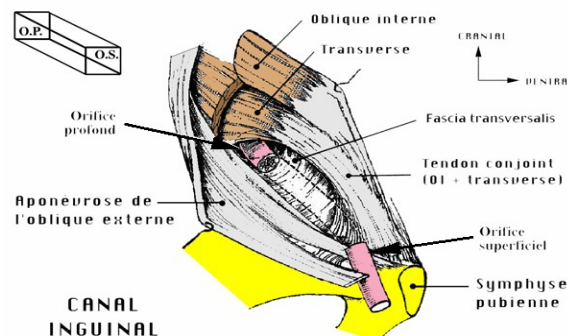
## A DIFFÉRENCIER DE:

- **Eventration:** issue de viscères abdominaux contenus dans un sac péritonéal et s'extériorisant par un orifice non naturel de la paroi abdominale (secondaire à une laparotomie, ou une plaie de la paroi abdominale).
- **Eviscération:** issue de viscères abdominaux en dehors de la cavité péritonéale, provoquée par la désunion d'une plaie opératoire.
- **Diastasis:** écartement de 2 muscles (ex: grands droits), sans orifice véritable, avec issue possibles de viscères abdominaux protégés par un sac péritonéal.

## ANATOMIE :

Le canal inguinal:

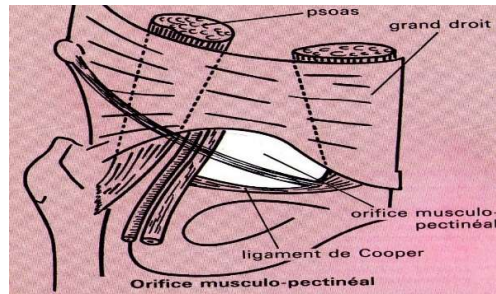
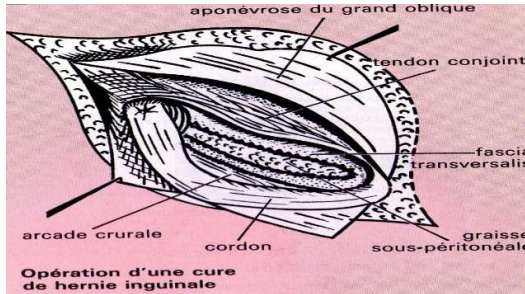
- Est un interstice ménagé dans l'épaisseur de la paroi abdominale par ou émerge:
  - Le cordon spermatique chez l'homme.
  - Le ligament rond chez la femme.
- Son trajet est complexe: c'est un tunnel qui part de la cavité abdominale vers l'extérieur,
- Son trajet en chicane emprunte d'abord l'orifice inguinal profond, puis l'orifice inguinal superficiel (plus bas et plus en dedans que le précédent, proche de la ligne médiane).
- La longueur du canal inguinal est d'environ 4 cm.



Le canal inguinal contient 4 parois:

1. La paroi antérieure du canal est formée par le muscle oblique externe.
2. La paroi supérieure est formée par la réunion des tendons des muscles oblique interne et transverse (tendon "conjoint").
3. La paroi inférieure est formée par l'arcade fémorale (autrefois crurale).
4. La paroi postérieure n'est formée que du fascia Transversalis, simple feuillet fibreux revêtant le péritoine.

L'ensemble forme un canal dirigé en avant, en bas et en dedans.

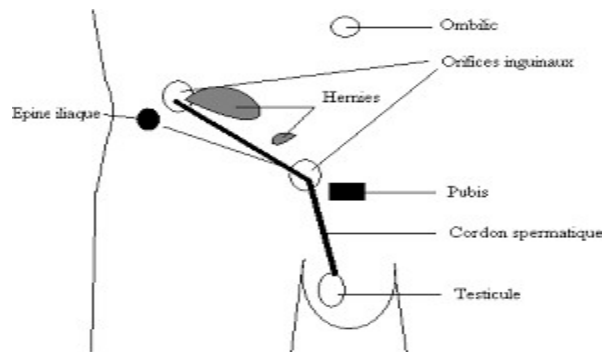


Anatomiquement, son abord de la superficie à la profondeur, rencontre les éléments suivants:

- La peau, le tissu cellulaire sous cutané
- L'aponévrose du grand oblique
- Le tendon conjoint.
- Puis le fascia transversalis dans lequel s'ouvre l'orifice inguinal profond.

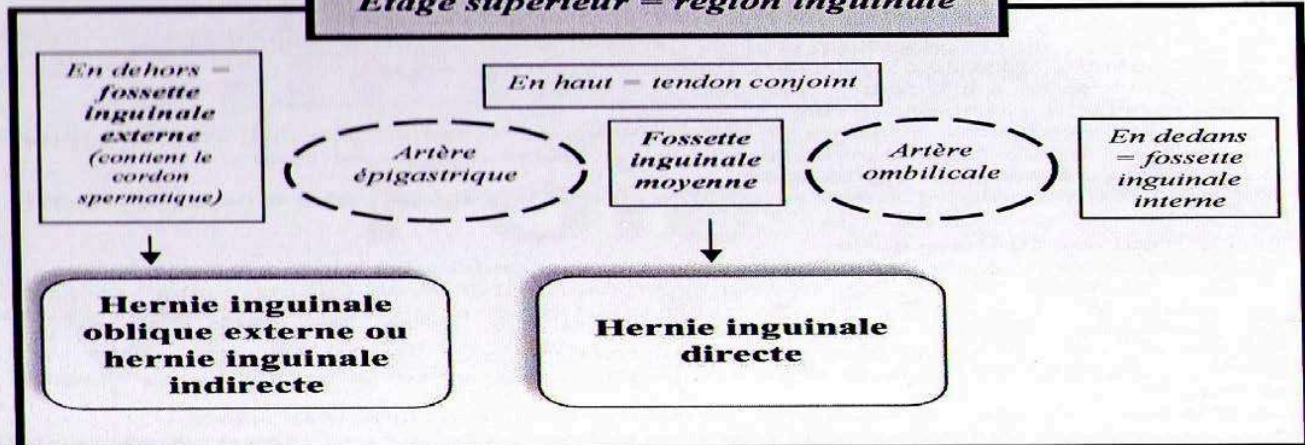
## SITUATION :

- Il est sur une ligne tendue de l'épine pubienne à l'épine iliaque antéro-supérieure → (**ligne de malgaigne**).
- Il répond à la moitié interne de cette ligne.
- Il fait, avec la direction de l'arcade crurale, un angle très aigu.

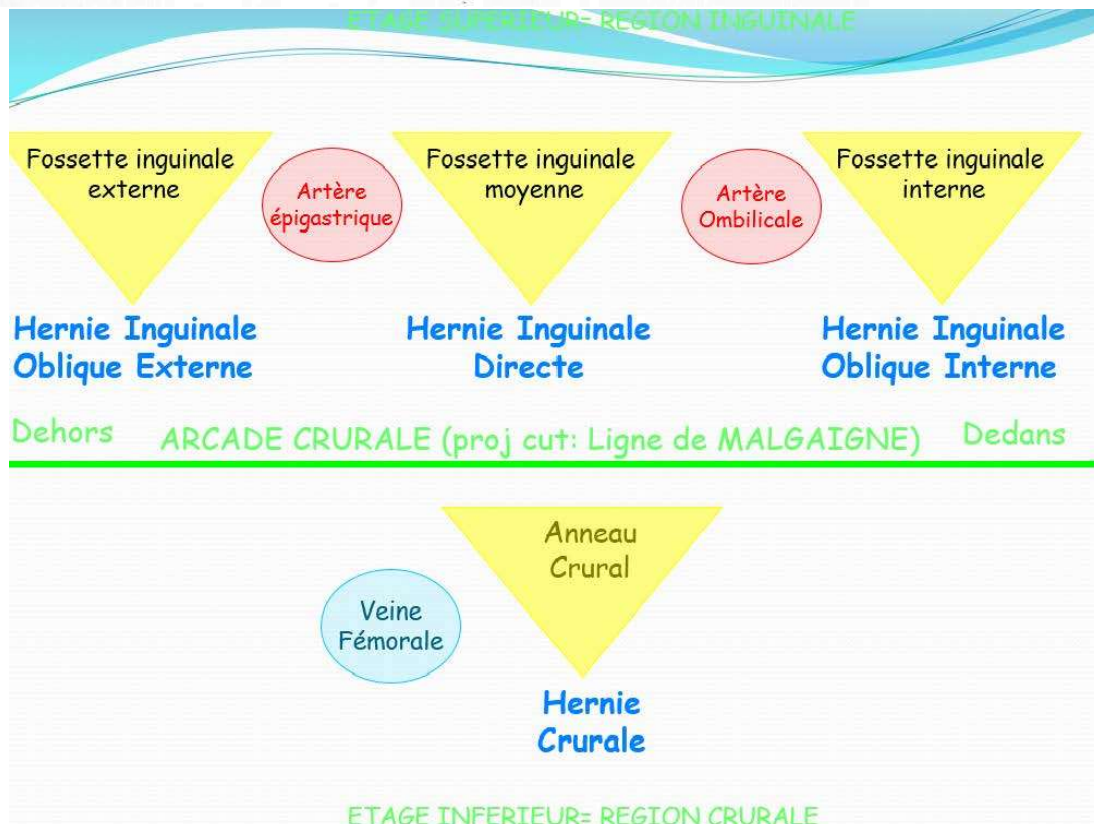
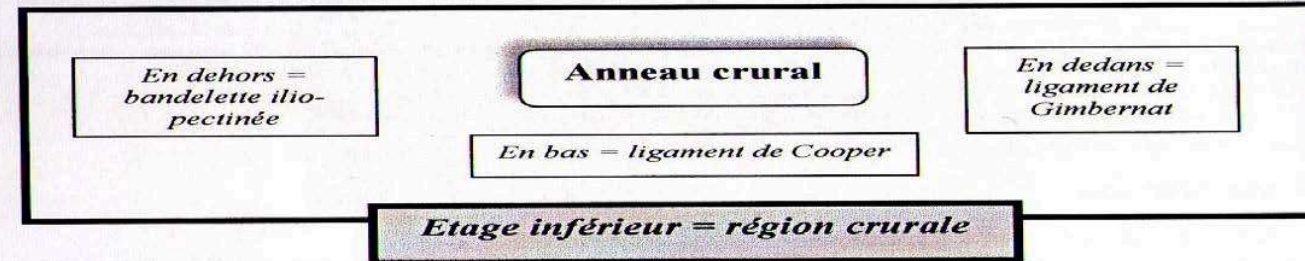


# ANATOMIE DE LA REGION DE L'AINE

## Etage supérieur = région inguinale



**Ligne de Malgaigne = projection cutanée de l'arcade fémorale = ligne tendue entre ELIAS et épine du pubis**



- Toutes les hernies (inguinales ou crurales) sont définies par le franchissement du fascia transversalis qui est distendu ou repoussé (Il correspond au feuillet profond de l'aponévrose du transverse).
- **EN PATHOLOGIE**, toute distension de la paroi abdominale dans la région inguinale, va entraîner l'apparition d'une hernie (qui sera inguinale ou crurale selon son trajet par rapport à l'arcade crurale).

## HERNIE INGUINALE :

- Située au-dessus de la ligne de Malgaigne (=projection cutanée de l'arcade fémorale)+++.
- Très fréquente chez l'homme.
- Le diagnostic repose sur le seul examen clinique (bilatéral et comparatif+++).
- hernie simple = tuméfaction indolore, réductible, impulsive à l'effort et à la toux.

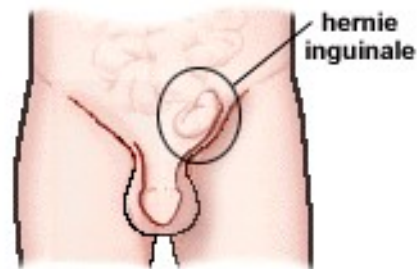
## EXAMEN CLINIQUE :

### **Interrogatoire:**

- Date et modalités apparition :
  - Récente / ancienne.
  - Brutale / progressive.
  - Récidive.
  - Amaigrissement

### **Signes fonctionnels :**

- Gêne, pesanteur, tiraillement.
- Douleur à l'effort.
- Troubles digestifs.
- Retentissement physique et professionnel.
- Conditions de vie: actif, sportif, sédentaire.
- Recherche de facteurs de risques.
- Antécédents médicaux et chirurgicaux.



### **Signes généraux :**

- Absent si forme non compliquée.

### **Signes physiques:**

- Examen debout puis couché, avec effort de toux.
- **Inspection:** parfois normale; sinon, tuméfaction impulsive à la toux, apprécier état cutané local; inspecter les bourses.
- **Palpation: élément essentiel du diagnostic+++ :**
  - L'extrémité de l'index coiffe la peau du scrotum.
  - Tuméfaction impulsive à la toux, non douloureuse, réductible, reproductible.
- **Percussion:** souvent normale. Si hernie volumineuse:
  - Mat: contenu épiploïque.
  - Tympanique: grêle, colon.
- **Auscultation:** souvent normale, parfois, BHA si grêle ou colon.
- **Examen systématique des autres orifices herniaires++.**
- **Toucher rectal++:** tumeur, adénome prostatique.
- **Examen général:** pulmonaire, ascite...

### **Fondamental :**

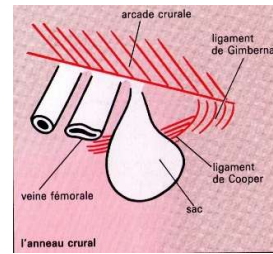
En dehors des examens complémentaires nécessaires au bilan préopératoire, aucun autre examen ne doit être demandé.

Le diagnostic de la hernie de l'aîne est clinique.



## HERNIE CRURALE :

- Collet au-dessous de la ligne de Malgaigne.
- Fréquence: 15%; femme+++; âgée++.
- Trajet: orifice crural; en dedans des vaisseaux fémoraux.
- Taille: souvent petite → **RISQUE D'ETRANGLEMENT.**
- Cliniquement:
  - Tuméfaction partie supéro-interne du triangle de Scarpa.
  - Rechercher en décubitus dorsal, cuisse en abduction, jambe pendante hors du lit.
  - Diagnostic difficile si obésité.



## FORMES ETIOLOGIQUES :

### HERNIES CONGENITALES :

- Persistance canal péritonéo vaginal (ou canal de Nuck chez la femme).
- Toujours++ oblique externe (trajet intra funiculaire) → Fossette inguinale externe.
- Terrain: nourrisson, enfant, adulte jeune.
- Malformations associées: kyste cordon ou épididyme, hydrocèle vaginale.

### HERNIES ACQUISES :

- Faiblesse musculo aponévrotique région inguinale.
- Inguinale oblique externe le plus souvent.
- Inguinale directe ou crurale; très rarement oblique interne.
- Terrain: adulte et vieillard; homme > femme.

#### Facteurs favorisants :

##### **Faiblesse musculo-aponévrotique :**

- Âge.
- Sédentarité.
- Obésité.
- Amaigrissement brutal.

##### **Hyperpression abdominale :**

- Insuffisance respiratoire : BPCO, toux.
- Constipation.
- Adénome prostate (dysurie).
- Grossesse.
- Ascite.
- Effort physique.

## FORMES ANATOMIQUES :

### HERNIES INGUINALES OBLIQUES EXTERNES :

- Les plus fréquentes (50%).
- Trajet du cordon.
- Étiologie:
  - Toutes les hernies congénitales.
  - Une grande partie des hernies acquises.
- Développement:
  - Vers les bourses chez l'homme.
  - Vers les grandes lèvres chez la femme.
- De la pointe herniaire à la volumineuse hernie inguino-scrotale
- Cliniquement: réduction en haut, en arrière et en dehors, perception en dehors de l'artère épigastrique

## HERNIES INGUINALES INDIRECTES :

- Hernies de faiblesse - toujours acquises-
- Trajet: fossette inguinale moyenne.
- Taille: parfois volumineuse, mais jamais jusqu'au scrotum.
- Cliniquement :
  - Réduction antéropostérieure.
  - Perception en dedans de l'artère épigastrique

## HERNIES INGUINALES OBLIQUES INTERNES :

- Exceptionnelles.
- Trajet: fossette inguinale interne.
- Extériorisées à l'angle interne du canal inguinal.

## FORMES SELON LE CONTENU :

- Epiploon + intestin grêle : sont les plus fréquents.
- Colon : en particulier le sigmoïde du côté gauche.
- Vessie : corne vésicale dans les volumineuses hernies inguinales directes.
- Annexes :
  - Appendice : hernie de Littre.
  - Ascite : hernie se remplit en position debout, et se vide en position couchée.

## FORMES COMPLIQUEES :

### HERNIE ENGOUEE :

- Hernie difficile à réduire; parfois irréductible, mais non ou peu douloureuse; pas de signes occlusifs.
- **Menace d'étranglement++.**
- Indication opératoire formelle rapide, mais sans urgence.

### HERNIE ETRANGLEE :

- Complication grave → **URGENCE CHIRURGICALE.**
- Risque d'étranglement accru si:
  - Grand sac herniaire et collet étroit.
  - Hernie crurale.
- SIGNES FONCTIONNELS :
  - Douleur vive, installation brutale, continue, pénible.
  - Signes digestifs inconstants: nausées, vomissements, arrêt du transit rarement diarrhées.
- SIGNES GENERAUX: T°, TA, pouls, signes déshydratation.
- Examen clinique :
  - Tuméfaction de l'aîne (inguinale ou crurale)
  - Douloureuse, irréductible, non impulsive à la toux+++
  - Examen abdomen: météorisme abdominal, douleur diffuse.

Occlusion intestinale → palpation systématique des orifices herniaires.

- Risque : occlusion mécanique → nécrose → perforation.
- En faveur d'une souffrance viscérale : Fièvre, défense abdominale, signes inflammatoires locaux.

## DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

### DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA HERNIE INGUINALE :

- Hydrocèle (épanchement séreux de la vaginale testiculaire), Trans illumination.
- Varicocèle (=varice scrotale); tuméfaction molle, dépressible, disparaissant en position couchée.
- Orchiépididymite.
- Torsion testicule.

### DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA HERNIE CRURALE :

- Adénopathie crurale.
- Phlébite crosse saphène interne.
- Anévrisme fémoral.

## PRINCIPES DU TRAITEMENT :

### HERNIE INGUINALE NON COMPLIQUEE :

#### Principe :

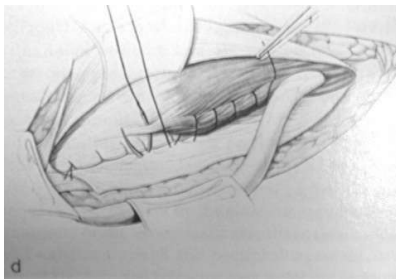
- Traitement du sac péritonéal: dissection ± résection ± fermeture.
- Traitement de la paroi abdominale: réfection pariétale ± renforcement.
  - **Réparation musculaire (Herniorraphies) :**
    - ❖ Bassini.
    - ❖ Shouldice (H inguinale).
    - ❖ Mac Vay (H crurale).
  - **Renforcement prothétique (Hernioplasties) :**
    - ❖ Intervention de Lichtenstein.
    - ❖ Plug + prothèses.

#### Voie d'abord :

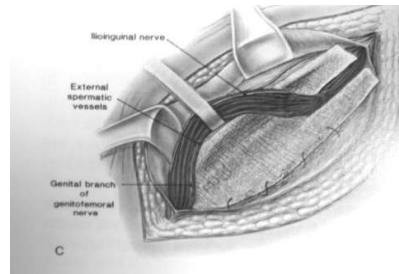
Inguinales, laparoscopie (TAPP, TEPP), pré péritonéales.

#### Indications :

- Hernie crurale : indication formelle.
- Hernie inguinale : sauf sujets à risques, ou pointe herniaire asymptomatique.



Herniorraphie



Hernioplastie

### HERNIE INGUINALE ETRANGLEE :

- **INTERVENTION CHIRURGICALE EN URGENCE++.**
- Selon la vitalité intestinale :
  - Satisfaisante: réintégration.
  - Nécrose: résection.
- Puis réparation pariétale (pas de prothèses).
- Mesures médicales :
  - Réanimation hydro électrolytique.
  - SNG.
  - Antibiothérapie.